כ"א בכסלו התשפ"ד
4 בדצמבר 2023
שה. 2023-4685

<u>השפעות אסדרה (RIA): תיקון הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון), התשפ"ג-2023</u>

דוח זה מעריך את השפעות הרגולציה שנקבעה (RIA) שעניינה עריכת שינויים בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופת חולים במסגרת תיקון הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון), התשפ"ג-2023 וכן שינויים בחוזר המאוחד - פרק 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי, וזאת בהתאם לסעיף 34 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021.

כללי

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 (להלן – **ההוראות**), קובעות פוליסה אחידה בביטוח הסיעודי הקבוצתי הנערך לחברי קופות החולים ומסדירות את תנאי הפוליסה ואת ההוראות למבטחים בביטוחים אלו. החוזר המאוחד - פרק 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי (להלן – **החוזר**) נלווה להוראות ומסדיר את אופן ניהולן ותפעולן של קרנות המבוטחים בביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים.
נוכח התמורות שחלו בנתוני התביעות המדווחות לרשות במסגרת חוזר ביטוח 2019-1-1 "תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3 - דיווח נתונים בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים" (24.02.2019), עלה צורך לעדכן את הכיסוי שנקבע בהוראות באופן שיביא לתחזית אקטוארית יציבה של קרנות המבוטחים בביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים (להלן – **קרן המבוטחים** או **קרנות המבוטחים**, לפי העניין). לאור האמור הוחלט לתקן את סעיפי ההוראות הקובעים את תנאי הכיסוי בביטוח זה. בנוסף, בהיעדר מבטחי משנה פעילים בשוק הסיעוד, הוחלט לבטל את תקרת המינימום לנטילת סיכון ביטוחי ע"י חברת הביטוח.

1. רקע אודות סביבת מושא האסדרה

א. רקע

הביטוח הסיעודי של קופות החולים מעניק כיסוי ביטוחי עבור כ-4.6 מיליון מבוטחים. הביטוח מתבסס על מודל אקטוארי ארוך טווח. במודל זה התביעות משולמות על ידי חברת הביטוח וקרן המבוטחים - בה גם נצברות רזרבות כספיות בהווה על מנת לממן עלות תביעות בעתיד - עם התבגרות חברי הקבוצה. זאת על מנת להבטיח את קיום הכיסוי בטווח הארוך וחלף עליית פרמיה בעתיד.
עד לשנת 2016, תכניות לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים התאפיינו בכך שתנאיהן נקבעו במשא ומתן בין המבטח לבין קופת החולים בתפקידה כבעל הפוליסה. בעל הפוליסה ייצג את חברי הקבוצה במשא ומתן עם המבטח בשם הקבוצה באמצעות מכרז שהתפרסם אחת לתקופה קצובה ובו נבחר מבטח. כמייצג של חברי קבוצת המבוטחים, בעל הפוליסה קבע את תנאי הפוליסה והחליט האם לחדשה, מתי ובאילו תנאים. בפעולות אלו היה בעל הפוליסה אחראי לייצג נאמנה את טובת המבוטחים.
במסגרת הסדרה כוללת של הביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים, נקבעו ההוראות הקובעות תנאים אחידים בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות החולים. ההוראות נכנסו לתוקף בשנת 2016, וקבעו

תנאים אחידים ביחס לכיסוי, אפשרו שקיפות והשוואה בין הפוליסות בקופות השונות, ומיקדו את התחרות באיכות השירות הניתן למבוטחים. השוני היחידי בין הקופות הינו המחיר והיבטים הקשורים לאיכות השירות והטיפול בתביעות בכל קופה. ההוראות מאפשרות מעבר רציף בין קופות חולים, ללא כל פגיעה בזכויותיהם בביטוח הסיעודי ובכך צומצמה ההשפעה על התחרות בין הקופות. במקביל פורסם חוזר נלווה להוראות הקובע הוראות עבור חברות ביטוח המבטחות תכניות אלו, ובין היתר מסדיר את אופן ניהולן של קרנות המבוטחים.

ב. תנאי הפוליסה האחידה

תנאי הפוליסה האחידה קובעים, בין היתר, כי דמי הביטוח עבור מבוטח ייקבעו בהתאם לגילו. סכום תגמול הביטוח החודשי שזכאי לו מבוטח מחושב לפי גילו במועד ההצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, ובהתאם למקום השהייה של המבוטח בתקופה שבשלה משולם לו תגמול הביטוח החודשי, כמפורט בטבלה שלהלן, המוצגת לפני הצמדה למדד* :

מקום השהייה של המבוטח	גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים לכיסוי ברובד הבסיסי		
	עד 49	50 עד 59	60 ומעלה
תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)	₪ 5,500	₪ 4,500	₪ 3,500
תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)	₪ 10,000	₪ 6,500	₪ 4,500

* מדד הבסיס להצמדת תגמולי הביטוח הינו המדד הידוע ליום 15.6.2016. לדוגמה, נכון לכתיבת מסמך זה, תגמולי הביטוח למבוטח עד גיל 49 השוהה בבית הינו כ – 6,100 ₪.

ג. הוראות נלוות לאופן ניהול קרן המבוטחים

ביטוח סיעודי נרכש, בדרך כלל, בגילאים צעירים בעוד שמקרה הביטוח מתרחש לרוב רק בגילאים מבוגרים. כמו כן, ההתקשרות שבין חברת הביטוח לבין קופת החולים היא לתקופה מוגבלת של מספר שנים. לכן יש להבטיח כי הביטוח יהיה זמין למבוטח בטווח הארוך ולמזער ככל האפשר את עליות דמי הביטוח בעתיד. לשם השגת מטרה זו נקבע בהוראות כי יש לנהל קרן לטובת המבוטחים, שבה יצברו כספים, אשר עתידים לשמש לכיסוי עלותן של ההתחייבויות ארוכות הטווח עבור המבוטחים, בניכוי הוצאות או בתשלום תוספות שיורה הממונה. נקבע כי חברת ביטוח המנהלת תכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח תנהל את סיכוני הביטוח בתקופת ההתקשרות עם קופת החולים וכן את קרן המבוטחים. התכנית תתבסס על מודל אקטוארי של בעל הפוליסה שיבוסס על אומדן מיטבי ("Best Estimate"), המתחשב, בין השאר, בניסיון התביעות של חברי הקופה ותכליתו איזון ארוך טווח בין דמי הביטוח המתקבלים מהמבוטחים לבין עלות הסיכון הביטוחי שלהם. חברת הביטוח תישא בסיכון ביטוחי שלא יפחת מ-20%.

ד. התשתית הרגולטורית הקיימת

להלן עיקרי האסדרה הרלוונטית שפורסמה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – **הרשות**) בעניין הביטוח הסיעודי לחברי קופת החולים :

- בשנת 2015 פורסמו הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) התשע"ו-2015, אשר קובעות את התנאים בתכניות ביטוח סיעודי לחברי קופת חולים, וכן את התנאים לגבי הצטרפות ועזיבה של מבוטחים. בהתאם להוראות, קופות החולים משמשות, עבור חבריהן הרשומים, כבעלות פוליסה בביטוח סיעודי קבוצתי המתנהל בחברות הביטוח.
- בשנת 2016 פורסם חוזר ביטוח 2016-1-3 "ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים", המפרט, מעבר לאמור בהוראות, את אופן ניהול קרנות המבוטחים בביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים. בהוראות נקבע כי יש לנהל קרן לטובת המבוטחים, שבה יצברו כספים, אשר עתידים לשמש לכיסוי עלותן של ההתחייבויות ארוכות הטווח עבור המבוטחים, בניכוי הוצאות או בתשלום תוספות שיורה הממונה. הוראות החוזר מתייחסות, בין היתר, לעקרונות שלפיהם חברת ביטוח תערוך ביטוח מסוג זה וכן לאופן ניהול כספי המבוטחים בקרן מבוטחים. בין מטרות החוזר ניתן למצוא את הצורך בניידות של הכספים הצבורים בקרן בין חברות ביטוח בסיומה של ההתקשרות עם קופת החולים, וכן ניהול אופטימלי של כספים בהתחשב במאפייני התחייבויות הביטוח. בכלל זה נקבע בחוזר האמור כי במשך תקופת הביטוח חברת הביטוח תישא בסיכון הביטוחי הגלום בתכנית בשיעור שלא יפחת מ-20%.
- בשנת 2020 פורסם תיקון להוראות אשר אפשר את הרחבת הכיסוי הניתן במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי הנערך לחברי קופות החולים כחלופה לביטוחי הפרט ששיווקם הופסק. בהוראות נקבע כי קופות החולים יוכלו להציע למבוטחים שרכשו את הכיסוי הקיים, לרכוש פוליסת סיעוד קבוצתית לחברי קופות החולים הכוללת רובד מורחב, זאת בכפוף להליך חיתום רפואי ובתוספת תשלום. שינויים אלו נועדו להרחיב את היקף ואורך הכיסוי הסיעודי שלהם.

2. הגדרת הצורך באסדרה

הרשות מקיימת בקרה שוטפת על קרנות המבוטחים בביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים על מנת להבטיח את יציבותן של קרנות המבוטחים לטווח הארוך. בשנים האחרונות נצפתה מגמה של עלייה במספר התביעות המוגשות והמשולמות. נוכח הפער שנוצר בין נתוני התביעות בפועל ובין התחזית העומדת בבסיס התמחור האחרון שבוצע קיים חשש ליציבות הקרנות וליכולת שלהן לעמוד בהתחייבות לתשלום תביעות עתידיות של חברי הקבוצה. כמו כן, על אף שבכל הקופות קיים מתווה לעלייה הדרגתית של הפרמיות, על פי הערכות הרשות, במרבית הקרנות המתווה הקיים אינו מספיק בכדי להביא לתחזית מאוזנת לטווח הארוך. המשמעות היא כי יש צורך לנקוט בפעולה לייצוב קרנות המבוטחים על מנת שאלו יוכלו להבטיח כיסוי עבור חברי הקבוצה לטווח הארוך.

כיום, ישנם הבדלים בגובה הצבירה בקרנות המבוטחים בקופות השונות. הבדלים אלו נובעים, בין היתר, משוני בדמוגרפיה של חברי הקופות, גודל הקבוצה, שיעורי אישור תביעות, שיעורי זכאות לקצבאות הביטוח הלאומי וכן מניסיון העבר.

על כן, ובהתאם להוראות הדין שפורטו לעיל, ביום 1.8.2023 פורסמה טיוטת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון), התשפ"ג-2023 (להלן- **טיוטת ההוראות הראשונה**), במסגרתה הוצע לעדכן את הכיסוי הסיעודי הניתן לחברי קופות החולים באופן הבא:

א. הארכת תקופת ההמתנה מ-60 ל-180 ימים - שינוי זה צפוי להפחית את סך התשלומים למבוטחים שכן תוארך התקופה בה לא משולמים תגמולים למבוטחים ובכך יופחת הנטל על קרן המבוטחים.

השינוי ישפיע בעיקר על תביעות קצרות יחסית (עד לכחצי שנה) ובהתאם לא צפוי לפגוע במבוטחים שאירע להם מקרה ביטוח וזכאים לתגמולי ביטוח לתקופות ארוכות.

ב. **הפחתת גובה תגמולי הביטוח בכ-10%** - הוצע לעדכן את הצמדת תגמולי הביטוח החודשיים אל המדד הידוע ביום תחילתן של תיקון הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון), התשפ"ג-2023, וזאת בשונה מהמצב כיום, בו סכומי תגמולי הביטוח מוצמדים למדד הידוע מיום 1 ביולי 2016 (מועד תחילת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), תשע"ו-2015). שינוי זה יפחית את תגמולי הביטוח ובכך יפחית את הנטל על קרן המבוטחים, תוך הותרת סכום תגמולי הביטוח שהיה ידוע במועד קביעת ההוראות.

ג. **דחיית הכניסה לתוקף של הרובד המורחב** - על מנת לאפשר לקופות החולים ולחברות הביטוח זמן היערכות ונוכח הקשיים בהוספת רובד נוסף בתוך תקופת הסכמים קיימים, הוצע לעדכן את מועד התחילה של כל סעיפי ההוראות בנוגע לרובד המורחב ליום 1 בינואר 2028. יצוין כי עד כה טרם נכרתו הסכמים חדשים ולא נערכו חידושים בהסכמים קיימים מאז כניסתו של הרובד המורחב לתוקף, בחודש יולי 2021. בהתאם הרובד המורחב לא החל לפעול באף אחד מהביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בקופות חולים. לפיכך, מוצע שמועד כניסתו של הרובד הנוסף תידחה מיום 1 ביולי 2021 ליום 1 בינואר 2028. שינוי זה לא צפוי לפגוע בחברות הביטוח, בקופות החולים ובציבור המבוטחים.

3. **בעלי העניין אשר יושפעו מהאסדרה**

א. **המבוטחים** - מהאסדרה יושפעו באופן ישיר המבוטחים בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות החולים, אשר יחוו הפחתה בכיסוי הקיים להם בפוליסה. מאידך, ללא פעולות אלו קרנות המבוטחים בחלק מן הקופות עשויות להגיע למצב גירעוני ובו בכל מקרה יופחת הכיסוי ותעלה הפרמיה למבוטחים ואף תיעצר המכירה למבוטחים חדשים. פעולה מוקדמת נדרשת על מנת לייצב את הביטוח ולאפשר את המשך קיומו של הכיסוי.

ב. **חברות הביטוח** - חברות הביטוח יידרשו ליישם את השינוי בתנאי הפוליסה ובהליך יישוב התביעות. חברות הביטוח לא צפויות להיפגע מאסדרה זו מכיוון שהיא מפחיתה עבורן את הסיכון, שעלה באופן משמעותי בשנים האחרונות. ייתכן כי מהלכים אלו של הפחתת הכיסוי והעלאת הפרמיה יעודדו את חברות הביטוח להמשיך ולבטח בתחום זה.

ג. **קופות החולים בכובען כבעלות הפוליסה** - ככל שלא ינקטו פעולות לאיזון קרנות המבוטחים והביטוח ייעצר בחלק מהקופות או יעבור למודל המשכי (כמפורט בהמשך), תיתכן פגיעה בקופות בהן יתרחש אירוע זה, זאת, מאחר שמבוטחים באותה קופת חולים עשויים לעזוב בשל היעדר כיסוי או לחילופין מבוטחים אחרים יימנעו מלעבור לקופה זו. בקופות החולים הללו עלולה להיות פגיעה תדמיתית.

4. **סקירה אודות אסדרה מקבילה או סותרת** - אין אסדרה מקבילה בנושא זה.

5. **סקירות של דין משווה**

כפי שעלה מסקירה של כיסויים בעולם שנערכה לקראת האסדרה המוצעת, המודל של הביטוח הקבוצתי לחברי קופות החולים הינו ייחודי ועל כן קשה להשוות את האסדרה הקיימת בו למקבילותיה בעולם. בהתאם, לא מצאנו מקום להסתמך על כללים המקובלים במדינות אחרות בעולם.

6. הליך מקדים לבחירת חלופה

א. היקף הנזק הקיים או הפוטנציאלי והיקף האוכלוסייה הרלבנטית

הביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים מעניק כיסוי ביטוחי ל-4.6 מיליון מבוטחים. שמירה על המצב הקיים תוביל לחוסר יציבות של הקרנות, דבר שישפיע הן על המבוטחים והן על נכונות מבטחים להשתתף במכרזים עתידיים. החשש הוא כי ללא התערבות רגולטורית, בשוק זה לא תהיה זמינות של כיסוי ביטוחי. הוראות הממונה קובעות כי במצב זה ניהול הקרן יתבצע ע"י המבטח האחרון שהתקשר עם בעל הפוליסה וזאת ללא נטילת סיכון מצד המבטח ומלוא הסיכון יושת על קרן המבוטחים עד להתרוקנותה. לא יתאפשר צירוף מבוטחים חדשים ותנאי הכיסוי יקבעו בהתאם לצבירה בקרן. בנוסף, לא יתאפשר מעבר מבוטחים בין הקופות.

ב. מורכבות הכלים הרגולטוריים הנדרשים להתמודדות עם הבעיה

השינויים שהוצעו דורשים עדכון הוראות ממונה. עם זאת בהתאם לאמור כל שינוי דורש שבעלי הפוליסה והמבטחים יבחרו להציע פוליסה לציבור.

ג. תקציב ממשלתי

לאסדרה שהוצעה לא צפויה השפעה תקציבית.

ד. עלויות

העלות הצפויה זניחה. עיקר העלות נובע מעדכון תנאי הכיסוי הדורש הוצאת מהדורת פוליסה חדשה ושליחתה לכלל המבוטחים. ייתכן שהשינויים יצריכו הדרכה למוקדנים ותגבור מענה למבוטחים.

ה. תחרות

מכיוון שהפוליסה היא אחידה בין קופות החולים, לאסדרה שהוצעה לא צפויה השפעה ישירה על רמת התחרות בין קופות החולים.

7. תיאור של החלופות המרכזיות שנסקרו לצד החלופות שנבחרו

א. חלופה 0 - שימור מצב קיים

- **תיאור החלופה** - המשך המצב הקיים ללא התערבות. בהתאם לחלופה זו, לא ייעשו פעולות אסדרה מצד רשות שוק ההון. במצב זה, הקרנות של חלק מהקופות עשויות להגיע למצב גרעוני בטווח הזמן הקרוב וייאלצו לעבור למודל המשכי בו הכיסוי בהן יצטמצם באופן משמעותי והפרמיות למבוטחים תעלינה באופן משמעותי. במצב זה יהיה קיים פער גדול בכיסוי המוצע לחברי הקופות השונות אשר עשוי להשפיע על התנהגות המבוטחים הן בהיבט של ביטול הביטוח לאוכלוסייה המבוגרת והן במעבר לקופות אחרות.
- **יתרונות** - לא דורש התערבות של הרשות ואין שינוי ברמת הכיסוי הקיימת של המבוטחים.
- **חסרונות** - המשך המצב הקיים יוביל בסבירות גבוהה לאזילה של חלק מקרנות המבוטחים ובהתאם לקריסה של הביטוח הסיעודי לחברי חלק מקופות החולים.
- **עלויות** - זניחות.
- **חסמים וקשיים** - לנוכח העלייה המשמעותית בשיעורי התביעות, קיים קושי שלא לפעול לאיזון בקרנות המבוטחים.
- **הערכת ישימות ואפקטיביות** - ישימות גבוהה, אפקטיביות נמוכה.

ב. חלופה 1 – הפחתה בכיסוי הביטוחי והארכת תקופת ההמתנה

- **תיאור החלופה** – בחלופה זו תקופת ההמתנה ממצב סיעודי ועד תחילת קבלת פיצוי מהפוליסה תתארך מחודשיים ל-6 חודשים ותגמולי הביטוח יופחתו בכ-10%. כיום, סכום הכיסוי למרבית המבוטחים עומד על קרוב ל-6,100 ש"ח ולאחר יישום חלופה זו יופחת סכום הכיסוי ל-5,500 ש"ח. בהתייחס למבוטחים הזכאים לתגמולים גם מהביטוח הלאומי, להערכת הרשות הם ייוותרו עם פיצוי חודשי הולם לצרכיהם.
- **יתרונות** - חלופה מצמצמת באופן מהותי את קצב השחיקה של קרנות הביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים. הפגיעה בכיסוי הינה מידתית ולא סותרת את מהותו.
- **חסרונות** – חלופה זו מגלמת פגיעה במבוטחים. במקביל, יתכן שבחלק מהקופות הפחתת הכיסוי לא תספיק לעצירת השחיקה בקרנות המבוטחים.
- **עלויות** – זניחות.
- **חסמים וקשיים** – הורדת זכויות מבוטחים מהווה פגיעה ביחס לכיסוי הקיים.
- **הערכת ישימות ואפקטיביות** – ישימות גבוהה, אפקטיביות גבוהה.

ג. חלופה 2 – הפחתת תגמולי הביטוח

- **תיאור החלופה** – בחלופה זו תגמולי הביטוח יופחתו בכ-15%. כיום, סכום הכיסוי למרבית המבוטחים עומד על קרוב ל-6,100 ש"ח ולאחר יישום חלופה זו יופחת סכום הכיסוי לכ-5,000 ש"ח. בהתייחס למבוטחים הזכאים לתגמולים גם מהביטוח הלאומי, להערכת הרשות הם ייוותרו עם פיצוי חודשי הולם לצרכיהם.
- **יתרונות** - חלופה מצמצמת באופן מהותי את קצב השחיקה של קרנות הביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים. הפגיעה בכיסוי הינה מידתית ולא סותרת את מהותו וכן לא ייפגעו תובעים בתביעות קצרות.
- **חסרונות** – חלופה זו מגלמת פגיעה במבוטחים ובפרט מבוטחים בעלי תביעות שמשכן ארוך יחסית.
- **עלויות** – זניחות.
- **חסמים וקשיים** – הורדת זכויות מבוטחים מהווה פגיעה ביחס לכיסוי הקיים.
- **הערכת ישימות ואפקטיביות** – ישימות גבוהה, אפקטיביות גבוהה.

ד. חלופה 3 – הגדלת תקופת ההמתנה לשנה, הקטנת תגמולי הביטוח ב-15%

- **תיאור החלופה** – בחלופה זו תקופת ההמתנה למבוטחי הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי כל קופות החולים תשתנה מחודשיים ל-12 חודשים. בשל שינוי זה, מבוטחים שתביעתם קצרה מ-12 חודשים לא יקבלו כלל תגמולי ביטוח ויתר המבוטחים יידרשו להמתין תקופה זו לפני קבלת תגמולי ביטוח. בנוסף תגמולי הביטוח יפחתו בכ-15%. חלופה זו היא קיצונית יחסית שכן היא מפחיתה באופן משמעותי את הכיסוי למבוטחים אך בהתאמה, עשויה להיות לה השפעה מיטיבה על מצב קרנות המבוטחים בשל הירידה בסיכון אליו הן חשופות.

- **יתרונות** – כיוון שהפחתת הכיסוי הביטוחי גבוהה יותר ביחס לחלופה 1, קיימת סבירות גבוהה יותר שתיבלם השחיקה בקרנות המבוטחים בכלל קופות החולים ושלא יהיה צורך בצעדי איזון נוספים.
- **חסרונות** – יפגע במבוטחים וידרוש מהם תקופת המתנה ארוכה ובמבוטחים החברים בקופות שקרן הביטוח הסיעודי שלהם יציבה.
- **עלויות** – זניחות.
- **חסמים וקשיים** – בחלופה זו קיימת פגיעה משמעותית בכיסוי.
- **הערכת ישימות ואפקטיביות** – ישימות בינונית, אפקטיביות גבוהה.

8. **בחירת חלופה** - החלופה שנבחרה במסגרת טיוטת ההוראות הראשונה היא חלופה 1 – העלאת תקופת ההמתנה לחצי שנה והתאמת הגמלה החודשית. החלופה נבחרה משום שהיא משלבת פגיעה מינימלית בתנאי הכיסוי תוך שיפור מהותי במצב הקרנות תוך שהיא מותירה את המבוטחים עם כיסוי בעל ערך. פיזור על מספר ממשקים והפעלת שינוי מינורי ככל הניתן בכל ממשק עדיפה על פגיעה קשה בקבוצה מסוימת, תוך שהרשות תשקול צעדים משלימים נדרשים.

9. **שיתוף הציבור בקביעת האסדרה**

א. **משכו של ההליך** – טיוטת ההוראות הראשונה פורסמה להערות הציבור לתקופה של 30 יום ובעקבות שינויים שנערכו בה, האסדרה פורסמה בשנית להערות הציבור לתקופה של 14 יום.

ב. **שיקוף תוצרי ההליך בדוח קביעת האסדרה** – בעקבות תהליך שיתוף הציבור התקבלו הערות מגורמים שונים לטיוטת ההוראות הראשונה. הרשות קיימה אף פגישות עם הגורמים אשר ביקשו לקיים פגישה מעבר להערות שהעבירו בכתב. להלן עיקרי הערות הציבור והתייחסות הרשות אליהן:

1. הארכת תקופת ההמתנה היא פגיעה קשה עבור המבוטחים. עבור חולי סרטן וחולים סופניים אחרים מדובר באיון של הכיסוי מאחר ואוכלוסייה זו אינה שורדת על פי רוב את תקופת ההמתנה.
2. הפחתת הכיסוי שנקבעה בטיוטת התיקון אינה מספיקה לייצוב קרנות המבוטחים. נדרשות פעולות משלימות כדוגמת עריכת שינויים בחוזר יישוב תביעות, החמרת הגדרת המצב המזכה (מעבר ל-4 ADL וכיו"ב) ושינוי תקופת ההתיישנות.
3. עריכת שינויים במודל הכיסוי והפיכתו למודל מודולרי בו גובה הכיסוי נקבע בהתאם למצבו הבריאותי של המבוטח ובהתאם רמת הכנסותיו.
4. גבייה דמי ביטוח מילדים והארכת החריג של 36 שנות חייו הראשונות של המבוטח.
5. ביטול הרף המינימלי לנטילת סיכון ע"י חברת הביטוח. נוכח היעדר מבטחי משנה יש חשש להמשך קיומן של תכניות הביטוח למבוטחים בביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים.

ג. **עדכון האסדרה המוצעת בעקבות הליך שיתוף הציבור** – לאחר ששקלה הרשות את ההערות שהתקבלו מהציבור הוחלט לערוך שינויים בטיוטת האסדרה וביום 26.9.2023 פורסמה טיוטה שנייה להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון), התשפ"ג-2023 (להלן- **טיוטה ההוראות השניה**), אשר כללה את השינויים הבאים:

1. תנאי הפוליסה המוצעים בטיוטת ההוראות השנייה יקבעו על פי המתואר בחלופה 2 חלף חלופה 1 שהוצעה בטיוטת ההוראות הראשונה;
2. יוארך החריג למקרה ביטוח שאירע ב-36 חודשיו הראשונים של המבוטח ל-60 חודשים;
3. ביטול התנאי לפיו חברת הביטוח תישא בסיכון של לכל הפחות 20%.

10. סיכום –

לאחר התייעצות עם הציבור והגופים הרלוונטיים הוחלט לבטל את הארכת תקופת ההמתנה וחלף זה גובה הכיסוי יעודכן בהתאם לחלופה 2. להלן טבלת הכיסוי החדשה:

מקום השהייה של המבוטח	גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים לכיסוי ברובד הבסיסי		
	עד 49	50 עד 59	60 ומעלה
תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)	₪ 5,000	₪ 4,100	₪ 3,200
תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)	₪ 10,000	₪ 6,500	₪ 4,500

נקבע כי הכיסוי לשוהה במוסד לא ישתנה מאחר ואחוזים בודדים ממשים את הכיסוי הניתן לשוהה במוסד והשפעת שינוי בכיסוי לשוהה במוסד היא זניחה.

נוסף על כך, יוארך החריג למקרה ביטוח שאירע ב-36 חודשיו הראשונים של המבוטח ל-60 חודשים. וזאת נוכח העובדה כי ככלל, מקרים אלה מהווים מקרים בהם מקרה הביטוח אירע עוד טרם הצירוף, אך נוכח הנסיבות טרם ניתן לאבחן את הילד כסיעודי טרם חלפו 60 חודשים.

עוד הוחלט לבטל את סעיף 1.3.6 סימן (א) סעיף (א) לחוזר במאוחד - פרק 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי הקובע נטילת סיכון ע"י החברה בגובה 20%. זאת על מנת לאפשר גמישות לקופת החולים לקבוע את גובה הסיכון המושת על חברת הביטוח בהתאם למאפיינים הייחודים של תכנית הביטוח בקופות השונות ולהגדיל את היתכנות להמשך קיומן של תכניות הביטוח.

יובהר כי הצד הנוגע לדחיית הרובד המורחב נותר בעינו.

11. הנגשת דבר האסדרה לציבור

לאחר שתהליך האסדרה יושלם, תפעל הרשות לפרסם את דבר האסדרה בדף הייעודי לכך באתר הרשות. פרסום האסדרה באתר יהיה מונגש לאנשים עם מוגבלויות, ויעשה שימוש בשפה פשוטה ובהירה, בצירוף דוח קביעת האסדרה. **כמו כן, 21 יום טרם השינוי בכיסוי ישלחו למבוטחים פוליסות מעודכנות.**